AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Repaso de última hora

# SALUD PÚBLICA

**15** temas · 1 página cada uno

Epidemiología & Bioética

5 temas ★★★ según preguntas reales 2013–2025 · plan de repaso de 7 días



# Índice

**Cómo usarlo.** Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.


## 01 Sistema de Salud Chileno, Red Asistencial & Vigilancia Epidemiológica

★★★ 21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial ..... 3
★★☆ 21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos ..... 4
★☆☆ 21.3. Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) ..... 5
★★★ 21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile ..... 6
★☆☆ 21.5. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario ..... 8
★★☆ 21.15. Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección ..... 9

## 02 Epidemiología Clínica, Bioestadística & Tamizaje

★★★ 21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales ..... 10
★★★ 21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud ..... 12
★★☆ 21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC ..... 14
★★☆ 21.9. Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos ..... 15
★★★ 21.10. Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos ..... 16

## 03 Bioética Clínica, Medicina Legal & Marco Regulatorio

★☆☆ 21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento ..... 17
★☆☆ 21.12. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad ..... 18
★☆☆ 21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia ..... 19
★★☆ 21.14. Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas ..... 20

**Números que tienes que saber** 21

**GES de la especialidad** 22

**Plan de repaso de 7 días** 23

**Índice por prioridad ★** 24

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA TIER 3

# 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

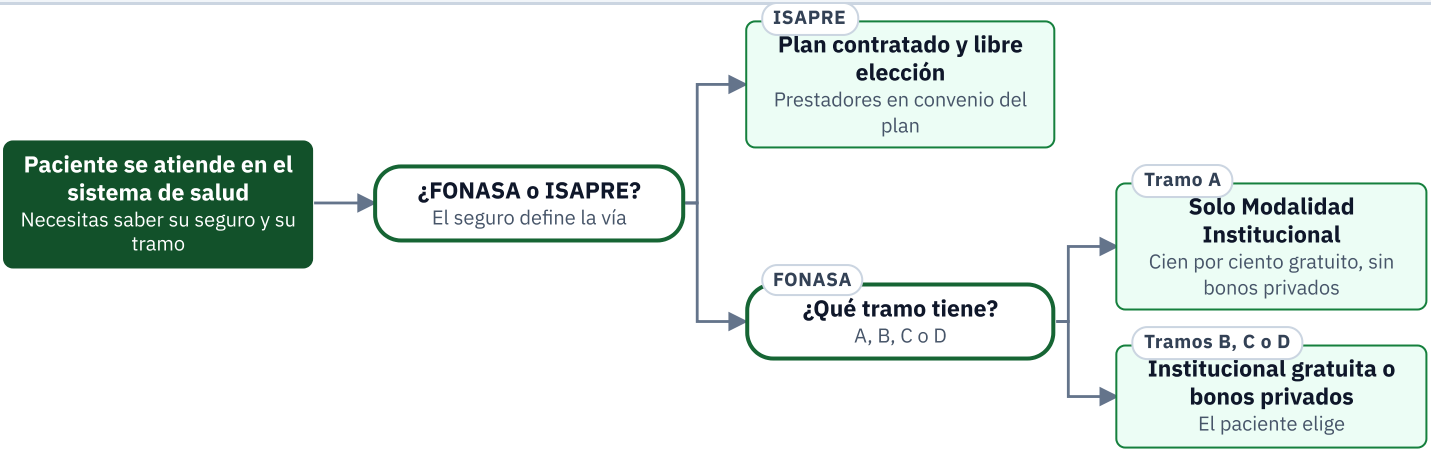
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.036 | Organización actual del sistema de salud chileno | Conocimiento general | 7.01.3.038 | Definición, estructura y funciones de los subsistemas en Chile | Conocimiento general |
| 7.01.3.039 | Concepto y descripción de la red asistencial chilena | Conocimiento general | 7.01.3.049 | Financiamiento del sector salud | Conocimiento general |
| 7.01.3.002 | Funciones esenciales de la Salud Pública | Conocimiento general | + 4 códigos relacionados: 7.01.3.033 · 7.01.3.034 · 7.01.3.035 · 7.01.3.037 | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **FONASA Tramo A**: Personas indigentes o sin ingresos; atención **100%** gratuita en MAI; NO tienen acceso a Modalidad Libre Elección (MLE).
- **Copago Cero (desde 2022)**: Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen gratuidad total (**0%** de copago) en toda la Red Pública (MAI).
- **Modalidad Libre Elección (MLE)**: Solo disponible para Tramos B, C y D mediante la compra de bonos en prestadores privados con convenio.
- **Atención Primaria en Salud (APS)**: Puerta de entrada regular obligatoria a la red pública; resuelve entre el **85%** y **90%** de las consultas.
- **SAPU vs SAR**: El SAR dispone de radiología digital osteopulmonar y laboratorio de respuesta rápida (troponinas, hemograma), permitiendo mayor resolutividad ambulatoria que el SAPU.

## ALGORITMO · TRAMO Y MODALIDAD: A QUÉ TIENE DERECHO EL PACIENTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.1 · TRAMOS DE FONASA: CLASIFICACIÓN, INGRESOS Y DERECHOS DE MODALIDAD

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-01

| TRAMO | NIVEL DE INGRESOS MENSUALES | COPAGO RED PÚBLICA (MAI) | DERECHO A LIBRE ELECCIÓN (MLE) |
|---|---|---|---|
| **Tramo A** | Carentes de recursos, indigentes, PRAIS | 0% (Gratuito) | NO tiene derecho a MLE |
| **Tramo B** | ≤ 1 Ingreso Mínimo Mensual | 0% (Gratuito) | SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3) |
| **Tramo C** | > 1 y ≤ 1,46 Ingresos Mínimos (o >3 cargas) | 0% (Copago Cero vigente) | SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3) |
| **Tramo D** | > 1,46 Ingresos Mínimos | 0% (Copago Cero vigente) | SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase sp-01

| ESCENARIO | RESPUESTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Laboratorio nacional de referencia** | Instituto de Salud Pública | Confundirlo con la Superintendencia de Salud |
| **Fiscaliza a FONASA, ISAPRES y prestadores** | Superintendencia de Salud | Responder Ministerio de Salud |
| **Paciente sin patología de urgencia, en la noche** | SAPU o SAR según disponibilidad | Ir directo al hospital de alta complejidad |

**REGLA DE ORO** **MINSAL norma, Servicios de Salud administran** — Superintendencia fiscaliza

**PRACTICA** **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **3–12, 37, 41–43** (págs. 10–11, 15–16) · solucionario págs. 25–26, 30–31.

**Clase 21.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TIER 3

# 21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

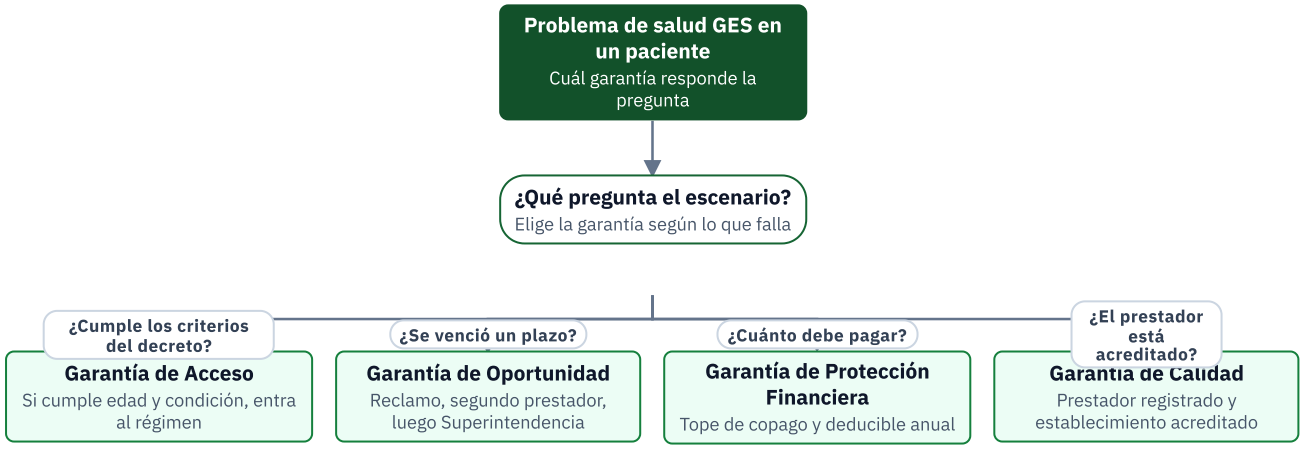
| | | |
|---|---|---|
| 7.01.3.040 | Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso | Conocimiento general |
| 7.01.3.047 | Auditoría y acreditación | Conocimiento general |
| 7.01.3.053 | Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda | Conocimiento general |
| 2.01.3.015 | Salud oral | Conocimiento general |
| 1.07.3.012 | Derecho GES a ayudas técnicas para personas de 65 años o más, como órtesis | Conocimiento general |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Las 4 Garantías GES son**: Acceso, Oportunidad, Protección Financiera y Calidad. Tienen rango de exigibilidad legal directa.
- Todo médico cirujano (público o privado) tiene la obligación legal de emitir el Formulario de Constancia GES ante sospecha o confirmación de un problema cubierto.
- Si se vence la Garantía de Oportunidad, el paciente reclama ante su asegurador (FONASA o ISAPRE), el cual tiene **48 horas** hábiles para designar un Segundo Prestador.
- El Segundo Prestador tiene un plazo legal de **10 días** corridos para otorgar la prestación requerida.
- Si el asegurador o el segundo prestador no responden en los plazos, el paciente acude a la Superintendencia de Salud, que designa un prestador en **48 horas**.

## ALGORITMO · LAS CUATRO GARANTÍAS: CUÁL SE APLICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.2 · LAS 4 GARANTÍAS LEGALES DEL RÉGIMEN GES (LEY 19.966)

| GARANTÍA | DEFINICIÓN LEGAL | MECANISMO DE EXIGIBILIDAD | CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| **Acceso** | Derecho a recibir atención si cumple criterios de inclusión | Ingreso en prestador de la Red GES oficial | Reclamo y obligatoriedad de ingreso forzoso |
| **Oportunidad** | Plazo máximo para diagnóstico, tratamiento y seguimiento | Cronograma estricto en Guías Clínicas GES | Designación de 2.° prestador en 48 h; luego Superintendencia |
| **Protección Financiera** | Copago máximo 20% (0% en FONASA) y Deducible tope | Mecanismo de pago por canasta y deducible anual | Reembolso inmediato de cualquier cobro improcedente |
| **Calidad** | Atención por profesionales y centros acreditados | Superintendencia de Salud (Registro de Prestadores) | Invalidez legal de la prestación y sumario sanitario |

## TRAMPAS EUNACOM

clase sp-02

| ESCENARIO | GARANTÍA VULNERADA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Prestador sin acreditación otorga cirugía GES** | Garantía de Calidad | Decir que no hay vulneración porque la cirugía salió bien |
| **Paciente de 58 años sin criterio etario GES** | Ninguna: no cumple Garantía de Acceso | Decir que se vulneró la Garantía de Oportunidad |
| **Plazo de cirugía GES vencido en el hospital** | Garantía de Oportunidad | Ir directo a un recurso judicial |

**REGLA DE ORO** **Acceso: si cumples el criterio, entras** — Oportunidad: los plazos

**PRACTICA** **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **13, 39** (págs. 12, 16) · solucionario págs. 27, 30.

**Clase 21.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# 21.3 Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

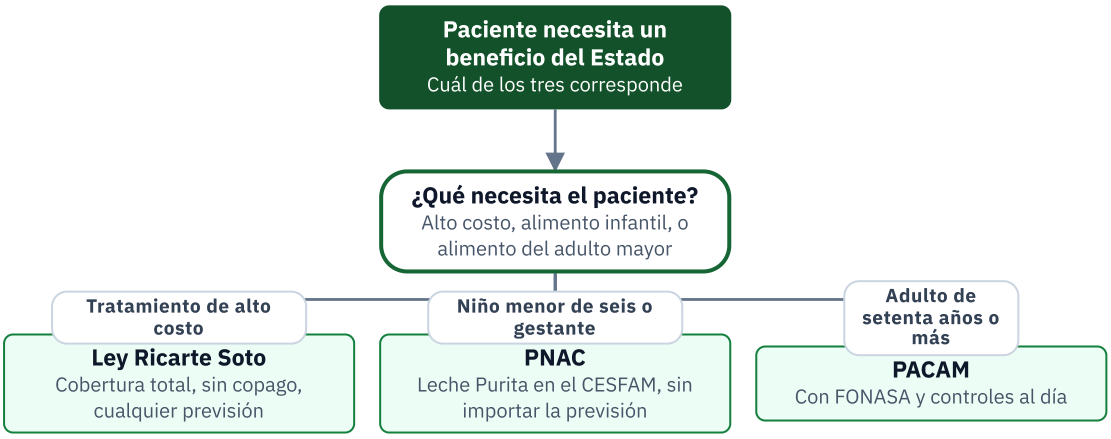
7.01.3.040 Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso — Conocimiento general

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ley Ricarte Soto**: Protección financiera universal para fármacos y dispositivos de alto costo; cubre a FONASA, ISAPRES, FFAA y particulares.
- **Copago en Ley Ricarte Soto**: Es **100%** gratuita para el beneficiario (**0%** de copago).
- **PNAC Universal**: Los niños menores de **6 años** y gestantes pueden retirar los alimentos del PNAC en el CESFAM sin importar si son FONASA o ISAPRE.
- **Alimentos del PNAC**: Purita Fortificada (**6-17 meses**), Purita Cereal (**18 meses** a **5 años 11 meses**) y Purita Mamá (embarazo y lactancia).
- **PACAM**: Beneficio para adultos de **70 años** o más en FONASA; entrega Crema Años Dorados y Bebida Láctea; exige EMPAM al día.
- **PNAC Especiales**: Cubre fórmulas hidrolizadas/aminoácidos en APLV y fórmulas para prematuros menores de **32 semanas** o **1.500 g**.

## ALGORITMO · A QUÉ BENEFICIO CORRESPONDE CADA PACIENTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.3 · COMPARACIÓN: LEY RICARTE SOTO VS RÉGIMEN GES

| CARACTERÍSTICA | LEY RICARTE SOTO (LEY 20.850) | RÉGIMEN GES (LEY 19.966) |
|---|---|---|
| **Población Objetivo** | 100% Universal (FONASA, ISAPRES, FFAA y sin previsión) | Afiliados a FONASA e ISAPRES |
| **Criterio de Inclusión** | Alto costo financiero que supera el umbral económico nacional | Prioridad sanitaria, morbimortalidad y años de vida perdidos |
| **Copago del Usuario** | 0% Gratuito siempre para todos los beneficiarios | Copago máximo 20% (según seguro y tramo) |
| **Tipos de Prestaciones** | Fármacos de alto costo, insumos y dispositivos específicos | Canastas integrales (diagnóstico, cirugía, hospitalización, fármacos) |
| **Garantías Legales** | Protección financiera integral para lo aprobado | Las 4 garantías legales (Acceso, Oportunidad, Protección y Calidad) |

## TRAMPAS EUNACOM

clase sp-03

| ESCENARIO | RESPUESTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Fármaco de alto costo en paciente ISAPRE** | Cobertura cien por ciento por Ley Ricarte Soto | Decir que solo aplica a FONASA |
| **Copago en tratamiento Ricarte Soto** | Cero por ciento, siempre | Aplicar el tope de veinte por ciento del GES |
| **Niño de ISAPRE, control al día** | Puede retirar la leche Purita en el CESFAM | Negar el retiro por no ser de FONASA |

**REGLA DE ORO** **Cubre a todos, sin importar el seguro** — FONASA, ISAPRE, FFAA o sin previsión

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, pregunta **44** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

**Clase 21.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA TIER 3

# 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

*Muy Alta · Pregunta clásica de examen distinguiendo ENO Inmediata (ante sospecha) vs ENO Diaria (confirmada)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.016 | Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes | Conocimiento general | 7.01.3.051 | Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades | Conocimiento general |
| 7.01.3.031 | Estrategias de control de enfermedades infecciosas | Conocimiento general | 7.01.3.015 | Usos de la epidemiología en el control de enfermedades | Conocimiento general |
| 7.01.3.027 | Investigación epidemiológica | Conocimiento general | | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- Las ENO Inmediatas se notifican ante la simple SOSPECHA clínica por la vía más rápida (Epivigila/teléfono); ¡nunca esperar confirmación de laboratorio!
- **Son ENO Inmediatas clásicas**: Meningococo, Hantavirus, Sarampión, Rubéola, Cólera, Botulismo, Rabia, Ántrax y brotes de ETA.
- **Son ENO Diarias**: Tuberculosis, Sífilis, VIH, Gonorrea, Hepatitis A, B y C, Coqueluche, Chagas y Tétanos.
- **Contactos de Meningococo**: Profilaxis con Rifampicina (**600 mg** c/**12 h** x 2 d) o Ciprofloxacino (**500 mg** VO DU); en embarazadas usar Ceftriaxona (**250 mg** IM DU).
- **Brotes de ETA**: La presencia de 2 o más personas con sintomatología digestiva similar tras compartir un alimento común constituye una ENO Inmediata.
- **Hantavirus**: NO tiene quimioprofilaxis profiláctica; se basa en la sospecha inmediata y traslado preventivo a centro con camas críticas (ECMO).

## ALGORITMO · INMEDIATA, DIARIA O CENTINELA: CÓMO SE DECIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.4 · ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA: INMEDIATA VS DIARIA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-04

| CATEGORÍA | MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN | VÍA DE COMUNICACIÓN | EJEMPLOS CARDINALES DE ENFERMEDADES |
|---|---|---|---|
| **ENO Inmediata** | Ante la simple SOSPECHA clínica (no esperar laboratorio) | Vía más rápida disponible (teléfono/Epivigila inmediato) | Meningococo, Hanta, Rabia, Sarampión, Cólera, Botulismo, Ántrax, Mpox, Brote ETA |
| **ENO Diaria** | Dentro de las 24 horas de confirmación o sospecha | Plataforma Epivigila / Formulario oficial diario | TBC, Sífilis, VIH, Gonorrea, Hepatitis A/B/C, Coqueluche, Chagas, Tétanos, Hidatidosis |
| **Vigilancia Centinela** | Muestreo poblacional periódico según centros centinela | Plataforma de vigilancia ministerial | Influenza, Virus Respiratorio Sincicial (VRS), Diarreas por Rotavirus |

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **14–15, 19–22** (págs. 12–13) · solucionario págs. 27–28.

**Clase 21.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

**TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA** clase sp-04

| TIPO DE VIGILANCIA | CUÁNDO SE NOTIFICA | EJEMPLOS |
|---|---|---|
| **Notificación diaria** | Dentro de veinticuatro horas de confirmar o sospechar | Tuberculosis, sífilis, VIH, hepatitis, coqueluche |
| **Brote de hepatitis A confirmado** | Notificación diaria a la SEREMI | Confundirla con una enfermedad de notificación inmediata |
| **Brote en un banquete: grupo cerrado** | Cohorte con tasa de ataque y riesgo relativo | Hacer casos y controles |
| **Un solo pico en un período de incubación** | Fuente común puntual | Transmisión persona a persona |
| **Tres documentos médico-legales de salud pública** | Notificación, certificado de defunción y licencia médica | Olvidar que son deberes con sanción |

**REGLA DE ORO** **Grave y poco frecuente** — Notificación inmediata, ante la sola sospecha

**¿POR QUÉ SE PREGUNTA?**

La vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles está regulada en Chile por el Decreto Supremo N.° 7 del Ministerio de Salud. Su conocimiento es de vital importancia médica y médico-legal, siendo una de las áreas más frecuentemente interrogadas en el EUNACOM. La distinción capital radica en las enfermedades de Notificación Inmediata (que deben notificarse obligatoriamente ante la simple sospecha clínica, sin aguardar confirmación bacteriológica o serológica) frente a las de Notificación Diaria.

**TABLA 21.4.B · INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE BROTES DE ETA (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS)**

| PASO DE LA INVESTIGACIÓN | OBJETIVO SANITARIO | HERRAMIENTA EPIDEMIOLÓGICA | MEDIDA DE CONTROL INMEDIATA |
|---|---|---|---|
| **1. Confirmar el Brote** | Verificar que ≥ 2 personas consumieron alimento común | Curva epidémica y tasa de ataque | Notificación inmediata a SEREMI de Salud |
| **2. Identificar el Alimento** | Determinar alimento causal con mayor riesgo relativo | Cuestionario alimentario y cálculo de Odds Ratio | Clausura preventiva de la cocina y decomiso de lotes |
| **3. Aislamiento Microbiológico** | Aislar Salmonella, Staphylococcus, etc. | Coprocultivos y análisis bromatológico del alimento | Tratamiento de afectados e hidratación oral/EV |

**PRACTICA** **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **14–15, 19–22** (págs. 12–13) · solucionario págs. 27–28.

**Clase 21.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
6 preguntas reales 2013–2025

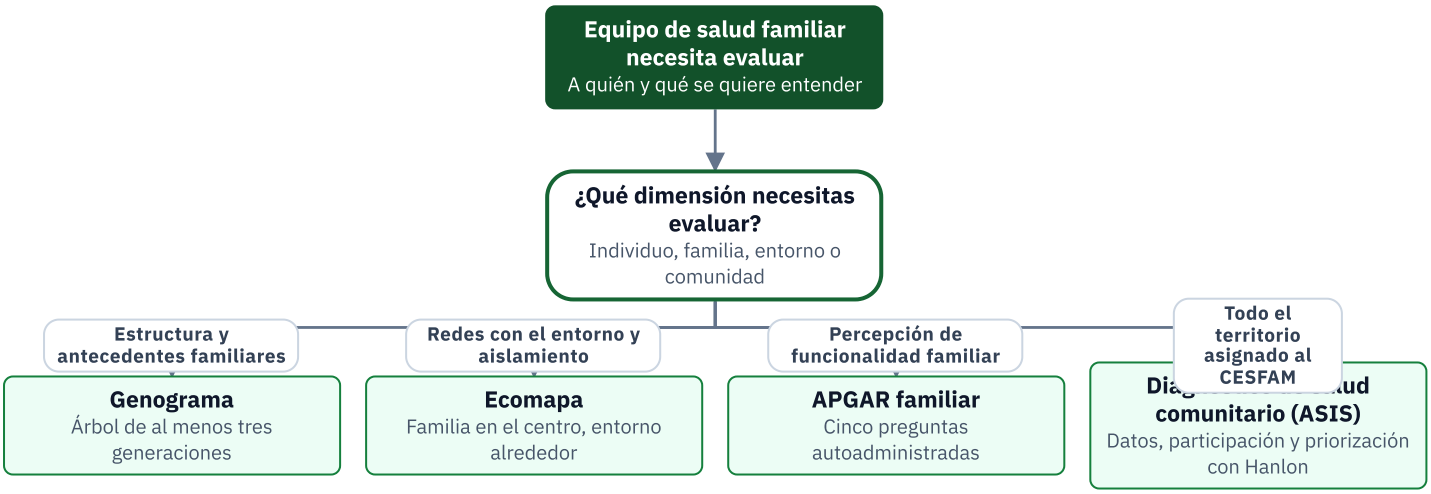
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.008 | Diagnóstico de situación de salud: | Conocimiento general | 7.01.3.010 | Etapas del diagnóstico de situación de salud | Conocimiento general |
| 2.01.3.005 | Familia y ciclo vital | Conocimiento general | 7.01.3.001 | Conceptos y definiciones de Salud Pública | Conocimiento general |
| 7.01.3.005 | Promoción de salud y prevención de enfermedades | Conocimiento general | + 4 códigos relacionados: 7.01.3.006 · 7.01.3.012 · 7.01.3.017 · 7.01.3.030 | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Principios del MAIS**: Centrado en las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado.
- **Genograma**: Mínimo 3 generaciones familiares; grafica edades, vínculos, fallecimientos y antecedentes mórbidos.
- **Ecomapa**: Muestra las relaciones y redes de apoyo de la familia con el entorno comunitario (escuela, trabajo, CESFAM).
- **APGAR Familiar**: Puntaje 7-10 (funcional), 4-6 (disfunción leve), 0-3 (disfunción severa). Evalúa adaptabilidad, participación, gradiente, afecto y resolución.
- **ASIS (Análisis de Situación de Salud)**: Proceso continuo que combina indicadores cuantitativos con diagnóstico participativo con la comunidad.

## ALGORITMO · QUÉ INSTRUMENTO DEL MAIS CORRESPONDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.5 · INSTRUMENTOS DE SALUD FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-05

| INSTRUMENTO | ESTRUCTURA Y COMPONENTES | OBJETIVO CLÍNICO-ASISTENCIAL | PUNTAJE / INTERPRETACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Genograma** | Árbol gráfico de 3 generaciones con símbolos estandarizados | Visualizar estructura biológica, patologías y vínculos | Estructural, dinámico y relacional |
| **Ecomapa** | Círculo familiar central rodeado de sistemas comunitarios | Evaluar redes de apoyo social y fuentes de estrés | Vínculos fuertes, débiles o estresantes |
| **APGAR Familiar** | 5 preguntas (Adaptación, Participación, Ganancia, Afecto, Recursos) | Medir percepción de satisfacción y funcionalidad familiar | 7-10: Buena función; 4-6: Disfunción leve; 0-3: Disfunción severa |
| **Círculo Familiar** | Círculo en blanco donde el usuario dibuja a sus miembros | Explorar cercanía emocional y jerarquías subjetivas | Apreciación cualitativa gráfica del paciente |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase sp-05

| INSTRUMENTO | QUÉ MIRA | OBJETIVO | PUNTAJE O LECTURA |
|---|---|---|---|
| **ASIS** | Toda la comunidad del sector | Priorizar problemas de salud con el método de Hanlon | Diagnóstico participativo, no un test individual |
| **Ciclo vital de Duvall** | Etapa de la familia | Anticipar problemas y crisis esperables | Ocho etapas; el cambio de etapa es crisis normativa |

**REGLA DE ORO** **Estructura y vínculos internos** — Genograma

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **16–17, 23–28, 45** (págs. 12–14, 17) · solucionario págs. 27–29, 31.

**Clase 21.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA TIER 3

# 21.15 Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.007 | Demografía y salud pública | Conocimiento general | 7.01.3.041 | Conceptos de administración y gestión | Conocimiento general |
| 7.01.3.042 | Planificación y programación en salud | Conocimiento general | 7.01.3.043 | Formulación de programas | Conocimiento general |
| 7.01.3.044 | Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones | Conocimiento general | + 2 códigos relacionados: 7.01.3.045 · 7.01.3.055 | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Proceso administrativo**: planificar, organizar, dirigir y controlar (evaluar); la evaluación retroalimenta la planificación.
- **Objetivo**: qué se quiere lograr; meta: cuánto y para cuándo (medible y con plazo).
- **Marco lógico**: fin, propósito, componentes y actividades, con indicadores, medios de verificación y supuestos.
- **Organización**: unidad de mando, jerarquía, tramo de control, división del trabajo; el organigrama representa la estructura formal.
- **Dirección**: liderazgo (autocrático, democrático, laissez-faire), motivación, comunicación y coordinación.
- **Índice ocupacional** = días cama ocupados / días cama disponibles × 100; giro de camas = egresos / camas; estada = días de estada / egresos.

## ALGORITMO · DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN A LAS MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.15 · LAS FUNCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

| FUNCIÓN | PREGUNTA QUE RESPONDE | HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS | EJEMPLO EN UN CESFAM |
|---|---|---|---|
| **Planificación** | ¿Qué haremos y cómo? | Diagnóstico, FODA, objetivos, metas, plan | Plan anual para subir la cobertura de control de hipertensos |
| **Programación** | ¿Cuántas actividades y con qué recursos? | Concentración, rendimiento, carta Gantt | Horas médicas y de enfermería para 600 hipertensos |
| **Organización** | ¿Quién hace qué? | Organigrama, división del trabajo, tramo de control | Equipos de cabecera por sector con un jefe |
| **Dirección** | ¿Cómo se pone en marcha al equipo? | Liderazgo, motivación, comunicación, coordinación | Reuniones de equipo y retroalimentación |
| **Evaluación y control** | ¿Se logró lo planificado? | Indicadores de estructura, proceso y resultado | Porcentaje de hipertensos compensados |

**REGLA DE ORO** **Base ancha: infecciosas y materno-infantil** — Base angosta: crónicas y envejecimiento

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **55, 73** (págs. 18, 21) · solucionario págs. 33, 37.

**Clase 21.15 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE TIER 3

# 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

*Máxima Rentabilidad · Pregunta fija en cada EUNACOM diferenciando Casos y Controles vs Cohortes vs Transversal vs ECA*

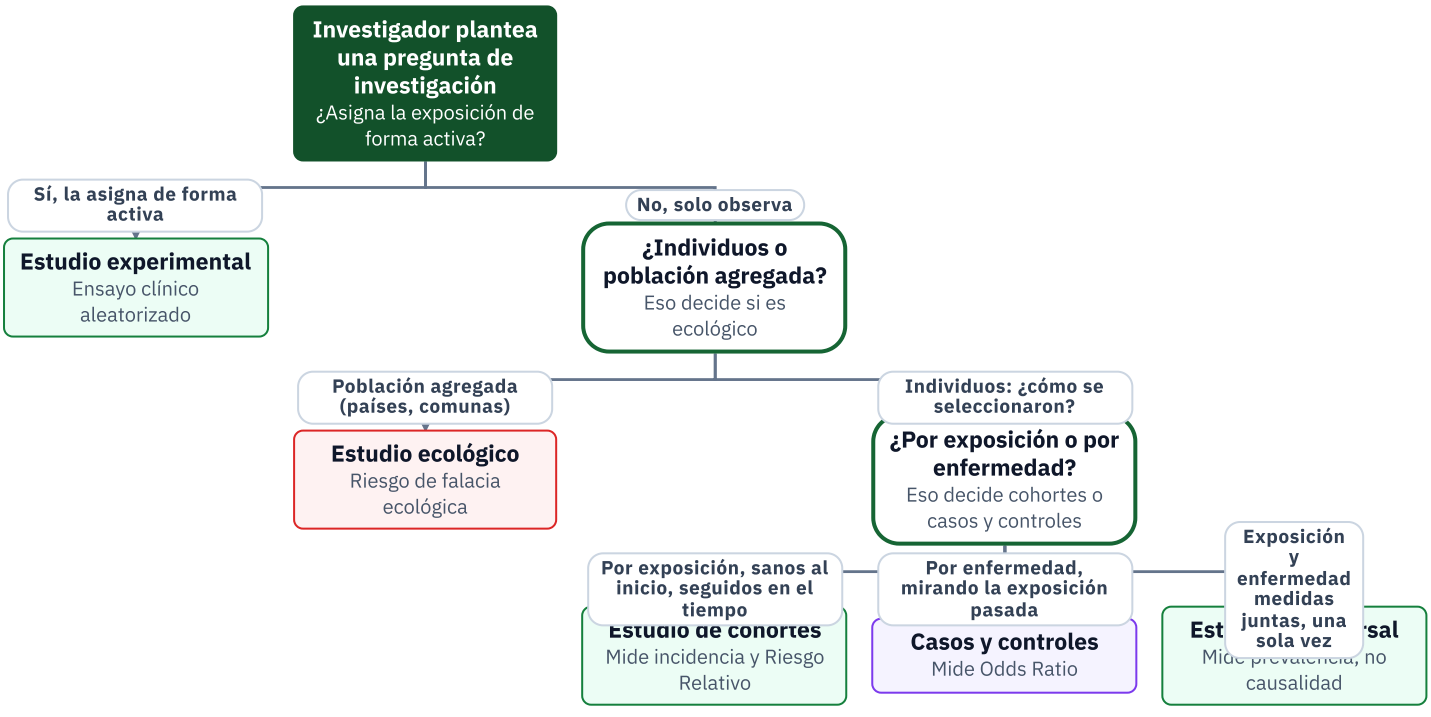
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.020 | Diseños de investigación epidemiológica | Conocimiento general | 7.01.3.022 | Estudios de casos y controles | Conocimiento general |
| 7.01.3.023 | Estudios de cohortes | Conocimiento general | 7.01.3.024 | Estudios experimentales y cuasiexperimentales | Conocimiento general |
| 7.01.3.013 | Concepto y campo de la epidemiología | Conocimiento general | + 3 códigos relacionados: 7.01.3.018 · 7.01.3.021 · 7.01.3.025 | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Casos y Controles**: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para patologías raras; medida: Odds Ratio (OR).
- **Cohortes**: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento; mide Incidencia directa y Riesgo Relativo (RR); óptimo para exposiciones raras.
- **Transversal**: Exposición y enfermedad medidas simultáneamente; calcula Prevalencia; NO permite probar causalidad por ambigüedad temporal.
- ECA: Estándar de oro de causalidad terapéutica; la aleatorización neutraliza factores de confusión conocidos y desconocidos.
- **Estudio Ecológico**: Unidad de análisis agregada (poblaciones, países); susceptible a la Falacia Ecológica (atribuir a individuos lo observado en grupos).
- **Fases de ECA**: Fase I (seguridad en sanos), Fase II (dosis en enfermos), Fase III (eficacia y registro frente a estándar), Fase IV (farmacovigilancia).

## ALGORITMO · QUÉ DISEÑO DE ESTUDIO CORRESPONDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **18, 29–36** (págs. 12, 14–15) · solucionario págs. 27, 29–30.

**Clase 21.6 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

# 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

**TABLA 21.6 · COMPARACIÓN METODOLÓGICA CARDINAL ENTRE DISEÑOS EPIDEMIOLÓGICOS**

| DISEÑO DE ESTUDIO | CRITERIO DE SELECCIÓN | DIRECCIÓN TEMPORAL | MEDIDA DE FRECUENCIA | MEDIDA DE ASOCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Transversal** | Muestra poblacional general | Un solo momento (simultáneo) | Prevalencia | Razón de Prevalencias / Odds Ratio |
| **Casos y Controles** | Por Enfermedad (Casos vs Controles) | Retrospectiva hacia el pasado | Proporción de expuestos | Odds Ratio (OR) |
| **Cohortes** | Por Exposición (Expuestos vs No Expuestos) | Longitudinal / Seguimiento en tiempo | Incidencia (IA o DI) | Riesgo Relativo (RR) |
| **Ensayo Clínico (ECA)** | Asignación aleatoria por investigador | Prospectivo experimental controlado | Incidencia del evento | Riesgo Relativo / Reducción Riesgo |
| **Ecológico** | Poblaciones completas (países, comunas) | Corte o series temporales | Tasas brutas poblacionales | Coeficiente de Correlación (r) |

**TRAMPAS EUNACOM** clase sp-06

| ESCENARIO | DISEÑO ÓPTIMO | PRINCIPAL RIESGO DE SESGO |
|---|---|---|
| **Enfermedad muy rara** | Casos y controles | Sesgo de memoria al recordar la exposición |
| **Exposición infrecuente** | Cohortes | Pérdidas de seguimiento de los sujetos |
| **Eficacia de un fármaco nuevo** | Ensayo clínico aleatorizado doble ciego | Pérdida de validez externa si los criterios son muy estrictos |

**REGLA DE ORO** **Por exposición, sanos al inicio** — Cohortes

**¿POR QUÉ SE PREGUNTA?**

La identificación precisa del diseño de un estudio epidemiológico a partir de una viñeta clínica metodológica es una de las preguntas cardinales de Salud Pública en el examen EUNACOM. Reconocer el criterio de selección de los participantes (por exposición en cohortes vs por enfermedad en casos y controles), la temporalidad (longitudinal vs transversal), la unidad de análisis (individual vs agregada en ecológicos) y el control de la exposición (observacional vs experimental aleatorizado) permite deducir inmediatamente la medida de asociación calculable y sus posibles sesgos.

**TABLA 21.6.B · FASES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA**

| FASE | POBLACIÓN SUJETO | OBJETIVO PRIMARIO | DISEÑO HABITUAL |
|---|---|---|---|
| **Fase I** | 20 a 80 voluntarios sanos | Seguridad, toxicidad, dosis máxima y farmacocinética | Abierto, no comparativo |
| **Fase II** | 100 a 300 pacientes con la enfermedad | Eficacia preliminar, curva dosis-respuesta y seguridad | Controlado, con o sin aleatorización |
| **Fase III** | 1.000 a 3.000+ pacientes con la patología | Confirmar eficacia frente a estándar o placebo (aprobación ISP/FDA) | ECA multicéntrico, aleatorizado, doble ciego |
| **Fase IV** | Población general que consume el fármaco | Farmacovigilancia post-comercialización, RAMs raras | Estudios observacionales a gran escala |

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **18, 29–36** (págs. 12, 14–15) · solucionario págs. 27, 29–30.

**Clase 21.6 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE TIER 3

# 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

★★★ PRIORIDAD ALTA
32 preguntas reales 2013–2025

*Máxima Rentabilidad · Ejercicios matemáticos obligatorios en el examen sobre cálculo e interpretación de RR, OR, RRR, RRA y NNT*

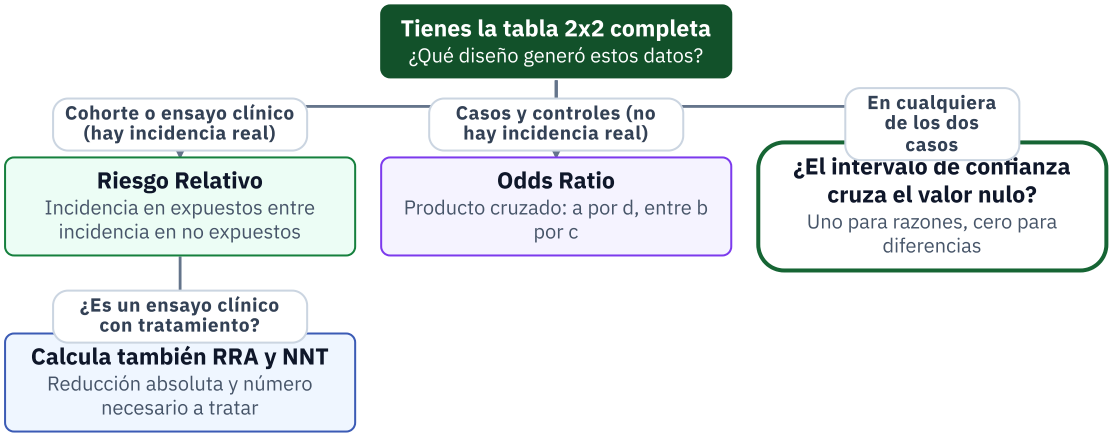
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.019 | Medidas de asociación e impacto | Conocimiento general | 7.01.3.014 | Epidemiología descriptiva | Conocimiento general |
| 3.01.3.007 | Mortalidad perinatal y materna | Conocimiento general | 3.01.3.012 | Salud pública perinatal | Conocimiento general |
| 7.01.3.009 | Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación | Conocimiento general | + 2 códigos relacionados: 7.01.3.029 · 2.01.3.014 | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Incidencia**: Casos nuevos en población libre de enfermedad en un período; Prevalencia: Casos totales existentes en un momento.
- **Riesgo Relativo (RR)**: Incidencia expuestos / Incidencia no expuestos; se calcula únicamente en Cohortes y Ensayos Clínicos.
- **Odds Ratio (OR)**: Razón de productos cruzados (a*d)/(b*c); se calcula en Casos y Controles.
- **Reducción Absoluta del Riesgo (RRA)**: Rc - Rt (diferencia matemática entre incidencias).
- **Número Necesario a Tratar (NNT)**: 1 / RRA (o 100 / RRA en porcentaje); siempre redondear al entero superior.
- **Significancia en IC 95%**: Si el intervalo de un RR u OR incluye el 1,0, NO existe significancia estadística (p ≥ 0,05).

## ALGORITMO · QUÉ MEDIDA CALCULAR Y CÓMO LEERLA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.7 · FORMULARIO ESENCIAL DE BIOESTADÍSTICA EUNACOM

| CONCEPTO | FÓRMULA MATEMÁTICA | INTERPRETACIÓN CLÍNICA | DISEÑO APLICABLE |
|---|---|---|---|
| **Incidencia Acumulada (IA)** | Casos nuevos / Población en riesgo al inicio | Probabilidad de enfermar en un período | Cohortes / Poblacional |
| **Riesgo Relativo (RR)** | [a/(a+b)] / [c/(c+d)] = I_exp / I_no_exp | Fuerza de asociación causal o protectora | Cohortes / Ensayos Clínicos |
| **Odds Ratio (OR)** | (a · d) / (b · c) | Razón de momios de exposición | Casos y Controles |
| **Reducción Absoluta (RRA)** | Rc - Rt (Incidencia control - Incidencia tto) | Beneficio neto real en la población | Ensayos Clínicos (ECA) |
| **Reducción Relativa (RRR)** | (Rc - Rt) / Rc = 1 - RR | Porcentaje del riesgo basal eliminado | Ensayos Clínicos (ECA) |
| **Número Necesario a Tratar** | NNT = 1 / RRA (o 100 / RRA%) | Pacientes a tratar para evitar 1 evento adverso | Ensayos Clínicos (ECA) |

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **2, 46–48** (págs. 10, 17) · solucionario págs. 25, 32.

**Clase 21.7 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

# 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

**TRAMPAS EUNACOM** — clase sp-07

| TE PREGUNTAN POR... | MEDIDA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Cuántas veces más riesgo hay en cohorte o ensayo** | Riesgo Relativo | Calcular Odds Ratio sin que sea casos y controles |
| **La asociación en un estudio de casos y controles** | Odds Ratio | Decir que el Odds Ratio es directamente el riesgo |
| **El beneficio real de un tratamiento** | Reducción absoluta y número necesario a tratar | Quedarse solo con la reducción relativa |
| **Si un intervalo de confianza es significativo** | Ver si incluye el valor nulo | Fijarse solo en el valor puntual del estimador |
| **Muertes por una enfermedad entre los enfermos** | Letalidad | Dividir por la población total |

**REGLA DE ORO** **Cohorte o ensayo clínico** — Riesgo Relativo

## ¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las preguntas de bioestadística matemática en el EUNACOM se concentran en el cálculo práctico de medidas de frecuencia (incidencia acumulada vs densidad de incidencia vs prevalencia), medidas de asociación (Riesgo Relativo en cohortes y ensayos, Odds Ratio en casos y controles) y medidas de impacto clínico farmacológico (Reducción Absoluta del Riesgo y Número Necesario a Tratar). Dominar las fórmulas algebraicas simples y su correcta interpretación clínica permite asegurar puntos vitales en el examen.

**TABLA 21.7.B · INTERPRETACIÓN DE INTERVALOS DE CONFIANZA (IC 95%) PARA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA**

| MEDIDA EVALUADA | VALOR NULO TEÓRICO | IC 95% SIGNIFICATIVO (P < 0,05) | IC 95% NO SIGNIFICATIVO (P ≥ 0,05) |
|---|---|---|---|
| **Riesgo Relativo (RR)** | 1,0 | No incluye el 1,0 (ej: 0,65 [0,45 - 0,85]) | Incluye el 1,0 (ej: 0,82 [0,62 - 1,15]) |
| **Odds Ratio (OR)** | 1,0 | No incluye el 1,0 (ej: 2,40 [1,35 - 4,20]) | Incluye el 1,0 (ej: 1,40 [0,85 - 2,30]) |
| **Reducción Absoluta (RRA)** | 0,0 (cero) | No incluye el 0,0 (ej: 4,5% [1,2% - 7,8%]) | Incluye el 0,0 (ej: 2,1% [-0,8% - 5,0%]) |
| **Diferencia de Medias** | 0,0 (cero) | No cruza el 0 (ej: -5,2 mmHg [-8,1 a -2,3]) | Cruza el 0 (ej: -2,0 mmHg [-5,0 a +1,0]) |

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **2, 46–48** (págs. 10, 17) · solucionario págs. 25, 32.

**Clase 21.7 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE TIER 3

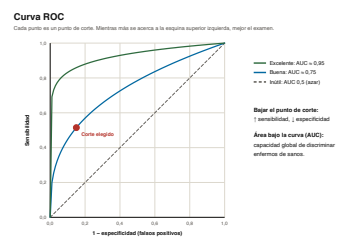
# 21.8 Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.028 Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas — Conocimiento general

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Sensibilidad**: Capacidad del test para detectar enfermos = VP / (VP + FN); alta sensibilidad con resultado negativo descarta la patología.
- **Especificidad**: Capacidad del test para identificar sanos = VN / (VN + FP); alta especificidad con resultado positivo confirma la patología.
- **Valores Predictivos**: VPP = VP / (VP + FP); VPN = VN / (VN + FN). Dependen directamente de la prevalencia de la enfermedad.
- **Efecto de la prevalencia**: A mayor prevalencia ➔ mayor VPP y menor VPN. A menor prevalencia ➔ menor VPP y mayor VPN.
- **Curvas ROC**: Gráfico de Sensibilidad (eje Y) vs 1 - Especificidad (eje X); mide la capacidad discriminativa global de un test continuo.
- **Área Bajo la Curva (AUC)**: AUC de 0,5 equivale al azar; AUC > 0,90 indica un test con excelente capacidad diagnóstica.




**CURVA ROC**
Dibujo propio (esquema)

## ALGORITMO · QUÉ PARÁMETRO CALCULAR Y CÓMO INTERPRETARLO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

**Tienes la tabla 2x2 frente al patrón de oro**
¿Qué te preguntan: el test o la población?

**Propiedad del test, no cambia con la población**
**¿Detectar enfermos o detectar sanos?**
Sensibilidad o especificidad

- **Detectar enfermos (para tamizaje)** → **Sensibilidad**: Verdadero positivo entre verdadero positivo más falso negativo
- **Detectar sanos (para confirmar)** → **Especificidad**: Verdadero negativo entre verdadero negativo más falso positivo

**Lo que significa el resultado en este paciente**
**¿Cuál es la prevalencia en esta población?**
Eso decide el VPP y el VPN

- **Prevalencia alta (especialidad, brote)** → **VPP alto, VPN más bajo**: Un positivo casi siempre es real
- **Prevalencia baja (tamizaje masivo)** → **VPP bajo, VPN alto**: Un positivo suele ser falso positivo

## TABLA 21.8 · TABLA DE CONTINGENCIA 2X2 Y DEFINICIONES MATEMÁTICAS

| RESULTADO DE LA PRUEBA | ENFERMOS (GOLD STANDARD +) | SANOS (GOLD STANDARD -) | TOTAL HORIZONTAL |
|---|---|---|---|
| **Prueba Positiva (+)** | Verdaderos Positivos (VP) | Falsos Positivos (FP) | Total Test (+) = VP + FP |
| **Prueba Negativa (-)** | Falsos Negativos (FN) | Verdaderos Negativos (VN) | Total Test (-) = FN + VN |
| **Total Vertical** | Total Enfermos = VP + FN | Total Sanos = FP + VN | Población Total = N |
| **Cálculo Intrínseco** | Sensibilidad = VP / (VP + FN) | Especificidad = VN / (VN + FP) | Independiente de prevalencia |
| **Cálculo Extrínseco** | VPP = VP / (VP + FP) | VPN = VN / (VN + FN) | Depende de la prevalencia |

## TRAMPAS EUNACOM

clase sp-08

| ESCENARIO | PREVALENCIA | COMPORTAMIENTO DEL VPP Y EL VPN |
|---|---|---|
| **Tamizaje poblacional masivo** | Baja | VPP baja mucho, muchos falsos positivos; VPN sube, cerca del cien por ciento |
| **Consulta de especialidad hospitalaria** | Alta | VPP sube fuerte, pocos falsos positivos; VPN baja |
| **Sensibilidad y especificidad del mismo test** | No cambian | Se mantienen iguales en ambos escenarios |

**REGLA DE ORO** **Sensibilidad y especificidad no cambian** — Son propiedades del test, no de la población

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **49–51** (págs. 17–18) · solucionario págs. 32–33.

**Clase 21.8 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

# 21.9 Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

*Alta · Evalúa tipos de sesgos (selección, memoria, Berkson), el fenómeno de confusión (confounding) y los criterios de causalidad de Hill*

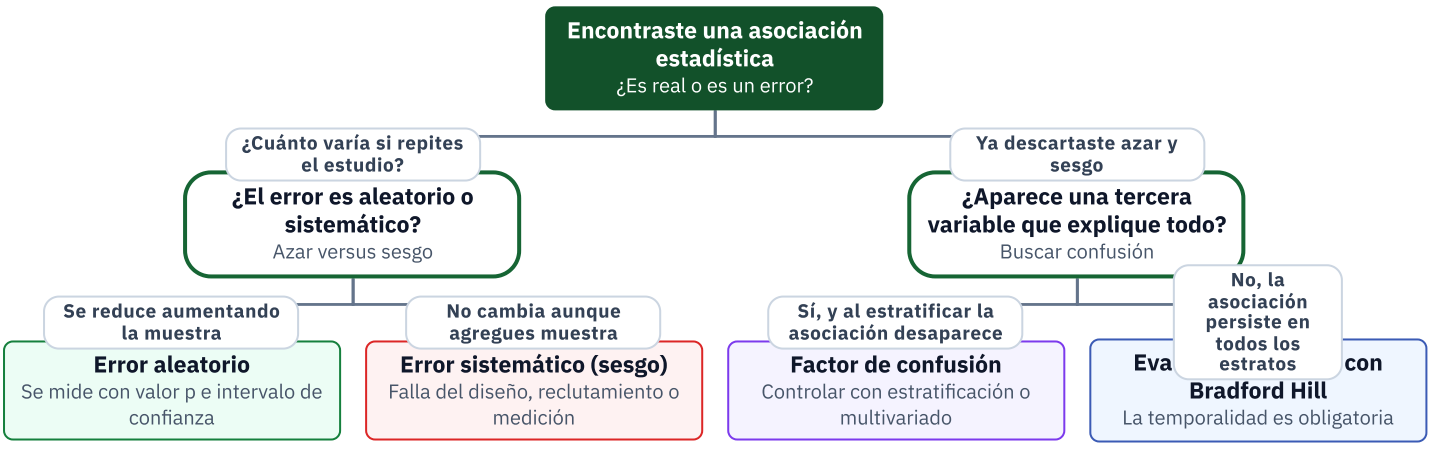
7.01.3.026 Causalidad y sesgos — Conocimiento general

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Error Aleatorio**: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se evalúa con valor p e IC **95%**.
- **Error Sistemático (Sesgo)**: Falla de diseño que altera la validez interna; NO se soluciona aumentando la muestra.
- **Sesgo de Memoria (Recall bias)**: Típico de Casos y Controles; el enfermo recuerda más la exposición que el sano.
- **Sesgo de Berkson**: Selección de sujetos en hospitales que distorsiona la frecuencia de factores de riesgo.
- **Variable de Confusión**: Asociada a la exposición, causa independiente del desenlace y NO es paso intermedio; se controla con estratificación o regresión multivariada.
- **Criterios de Bradford Hill**: Temporalidad es el ÚNICO criterio imprescindible (sine qua non); le siguen dosis-respuesta y consistencia.

## ALGORITMO · EVALUAR UNA ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA PASO A PASO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.9 · TIPOS CLÁSICOS DE SESGOS Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-09

| TIPO DE SESGO | MECANISMO FISIOPATOLÓGICO DEL ERROR | DISEÑO MÁS VULNERABLE | MÉTODO DE CONTROL O PREVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| **Sesgo de Berkson** | Selección de casos y controles en hospitales (mayor morbilidad) | Casos y Controles hospitalarios | Seleccionar controles de base comunitaria o poblacional |
| **Sesgo de Memoria (Recall)** | El enfermo recuerda mejor exposiciones pasadas que el sano | Casos y Controles | Usar registros médicos históricos objetivos o cegar al paciente |
| **Sesgo del Entrevistador** | El encuestador busca más la exposición si conoce el diagnóstico | Casos y Controles / Cohortes | Enmascaramiento (cegamiento) riguroso del encuestador |
| **Sesgo del Voluntario** | Los voluntarios son más motivados y sanos que la media | Ensayos Clínicos / Transversales | Muestreo aleatorio probabilístico representativo |
| **Factor de Confusión** | Tercera variable asociada a exposición y causa de enfermedad | Todos los observacionales | Estratificación, pareamiento o análisis multivariado |

**REGLA DE ORO** **El azar se arregla con más muestra** — El sesgo, nunca

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **52–54** (pág. 18) · solucionario pág. 33.

**Clase 21.9 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

# 21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

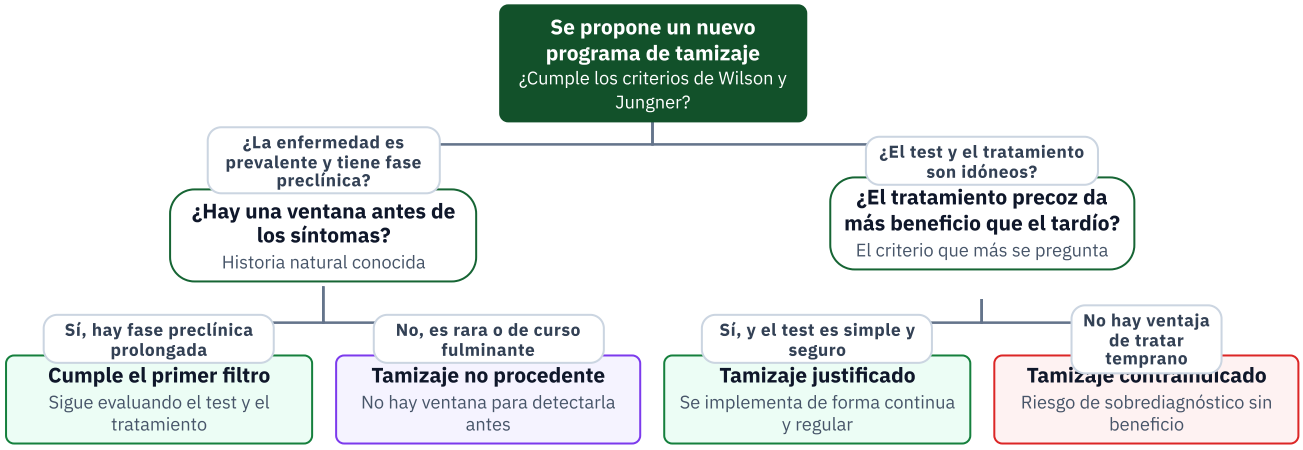
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.028 | Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas | Conocimiento general | 7.01.3.004 | Niveles de prevención | Conocimiento general |
| 7.01.3.003 | Historia natural de la enfermedad | Conocimiento general | 7.01.3.046 | Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación | Conocimiento general |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios de Wilson y Jungner**: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
- **Lead-Time Bias (Sesgo de Adelanto)**: Aumento aparente de la sobrevida por adelantar el momento del diagnóstico, sin modificar la fecha de la muerte.
- **Length-Time Bias (Sesgo de Duración)**: Mayor probabilidad de detectar tumores indolentes y de crecimiento lento, sobreestimando falsamente el beneficio del test.
- **Evaluación de Screening**: La eficacia real de un programa de tamizaje se demuestra ÚNICAMENTE con la reducción de la MORTALIDAD, no con la sobrevida a **5 años**.
- **Screening en Chile**: PAP en mujeres **25-64 años** (c/**3 años**), Mamografía en mujeres **50-69 años** (c/**2 años**), PKU/TSH neonatal universal.

## ALGORITMO · DECIDIR SI UN PROGRAMA DE TAMIZAJE ESTÁ JUSTIFICADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.10 · PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS DE TAMIZAJE EN EL SISTEMA DE SALUD CHILENO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-10

| PROGRAMA DE TAMIZAJE | POBLACIÓN OBJETIVO | PRUEBA EMPLEADA | PERIODICIDAD | FASE DETECTABLE |
|---|---|---|---|---|
| **Cáncer Cervicouterino (GES)** | Mujeres de 25 a 64 años | Papanicolaou (PAP) / Test VPH | Cada 3 años (PAP) o 5 años (VPH) | Neoplasia Intraepitelial (NIE I-III) |
| **Cáncer de Mama (GES)** | Mujeres de 50 a 69 años | Mamografía bilateral | Cada 2 años | Microcalcificaciones / Carcinoma in situ |
| **Hipotiroidismo y Fenilcetonuria** | Todos los recién nacidos vivos | Gota de sangre en papel filtro (PKU/TSH) | Al nacer (universal) | Trastorno metabólico antes de secuela |
| **Hipertensión y Diabetes (EMPA)** | Adultos de 20 a 64 años | Toma de PA, Glicemia y Colesterol | Cada 3 años en FONASA | Factores de riesgo antes de daño CV |
| **Displasia del Desarrollo de Caderas** | Lactantes a los 3 meses | Radiografía de pelvis AP | A los 3 meses de vida universal | Displasia acetabular antes de marcha |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase sp-10

| PROGRAMA | POBLACIÓN OBJETIVO | PRUEBA | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|
| **Vacuna contra el VPH** | Prevención primaria | Llamarla secundaria | Evita que aparezca |
| **Rehabilitación tras un infarto** | Prevención terciaria | Llamarla secundaria | Limita el daño |

**REGLA DE ORO** **Fase preclínica detectable** — Y un tratamiento que funcione mejor si se aplica temprano

**PRACTICA** **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **1, 38, 56–61** (págs. 10, 16, 18–19) · solucionario págs. 25, 30, 34–35.

**Clase 21.10 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO TIER 3

# 21.11 Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

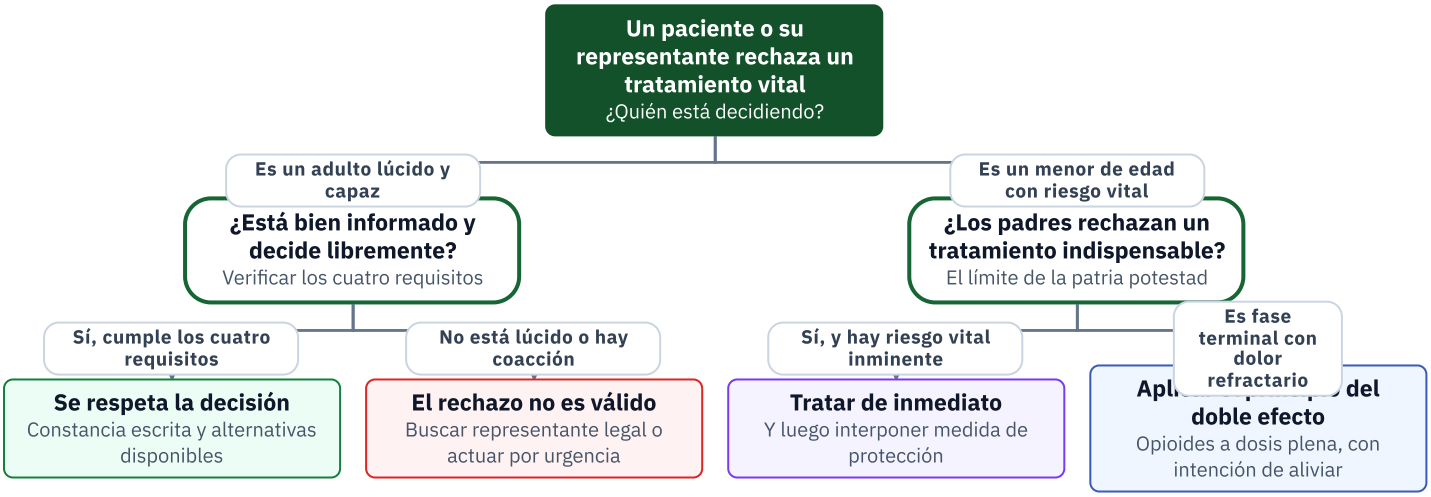
| | | |
|---|---|---|
| 7.01.3.052 | Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial | Conocimiento general |
| 7.01.3.056 | Conocimiento de los derechos y deberes del paciente | Conocimiento general |
| 2.01.3.013 | Relación médico-paciente-familia | Conocimiento general |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Principios de Beauchamp y Childress**: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
- **Adulto Competente**: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el médico DEBE respetar su autonomía.
- **Menor de Edad en Riesgo Vital**: Se DEBE transfundir y operar de inmediato; los padres no pueden disponer de la vida del hijo; interponer Medida de Protección.
- **Excepciones al Consentimiento**: Urgencia médica vital con riesgo de muerte/secuela grave en incapaz, y razones de Salud Pública (epidemias).
- **Principio del Doble Efecto**: Permite aumentar opioides en fase terminal para aliviar dolor refractario aunque deprima el sensorio o acorte la vida, si la intención exclusiva es calmar el sufrimiento.

## ALGORITMO · DECIDIR ANTE EL RECHAZO DE UN TRATAMIENTO VITAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.11 · LOS 4 PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA CLÍNICA DE BEAUCHAMP Y CHILDRESS

| PRINCIPIO BIOÉTICO | DEFINICIÓN CONCEPTUAL | APLICACIÓN CLÍNICA EN LA PRÁCTICA | LÍMITES O CONFLICTOS ÉTICOS |
|---|---|---|---|
| **Autonomía** | Capacidad de autogobernarse y decidir libremente | Consentimiento informado y rechazo de terapias en adultos | Incapacidad mental, coma o daño a terceros |
| **No Maleficencia** | Primum non nocere: no infligir daño activo ni omisivo | Evitar futilidad terapéutica y procedimientos dañinos | Prioridad jerárquica en menores con riesgo vital |
| **Beneficencia** | Actuar en pro del mayor beneficio para el paciente | Indicación de tratamientos médicos con respaldo clínico | No caer en el paternalismo médico autoritario |
| **Justicia Distributiva** | Distribución equitativa y solidaria de recursos de salud | Acceso universal GES y priorización transparente de camas | Triage en desastres y racionamiento de camas críticas |

## TRAMPAS EUNACOM

clase sp-11

| ESCENARIO | CONDUCTA OBLIGATORIA | FUNDAMENTO |
|---|---|---|
| **Adulto lúcido y capaz que rechaza** | Respetar; dejar constancia firmada | Prevalece la autonomía, Ley 20.584 |
| **Menor de edad en riesgo vital** | Transfundir u operar de inmediato | Interés superior del niño y derecho a la vida |
| **Adulto inconsciente, urgencia vital** | Actuar de inmediato | Consentimiento presunto, excepción de urgencia |

**REGLA DE ORO** **Adulto competente: manda la autonomía** — Aunque implique riesgo de muerte

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **62–67** (págs. 19–20) · solucionario págs. 35–36.

**Clase 21.11 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

# 21.12 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

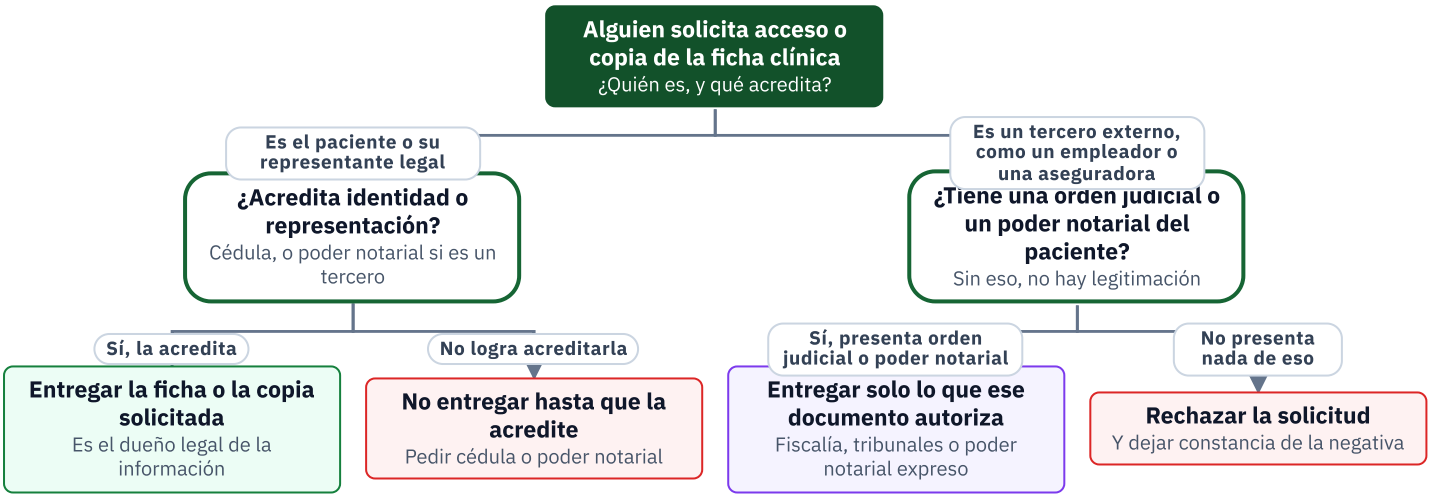
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.056 | Conocimiento de los derechos y deberes del paciente | Conocimiento general | 2.01.3.016 | Supervisión de salud- adolescente | Conocimiento general |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
- **Custodia de la Ficha**: El prestador debe conservarla por un plazo MÍNIMO DE 15 AÑOS desde la última atención.
- **Acceso Autorizado**: Paciente, representante legal, herederos del fallecido, tribunales/fiscalía y Superintendencia de Salud.
- **Acceso Prohibido**: Empleadores, aseguradoras sin poder notarial expreso, policías sin orden judicial y familiares de adultos competentes.
- **Trato Digno**: Prohibido fotografiar, grabar en video o exponer al paciente sin consentimiento escrito.
- **Ley de Consultorio Seguro**: Agrava sustancialmente las sanciones penales para quienes agredan verbal o físicamente a los funcionarios de la salud.

## ALGORITMO · DECIDIR SI ENTREGAR LA FICHA CLÍNICA A QUIEN LA SOLICITA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.12 · LEGITIMACIÓN DE ACCESO A LA FICHA CLÍNICA SEGÚN LA LEY 20.584

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-12

| SOLICITANTE | ¿TIENE ACCESO LEGAL DIRECTO? | REQUISITO EXIGIDO POR LEY | EXPLICACIÓN JURÍDICA |
|---|---|---|---|
| **El propio Paciente** | SÍ | Acreditar identidad con cédula de identidad | Es el dueño legal de su información clínica |
| **Representante Legal** | SÍ | Certificado de nacimiento o poder notarial | Actúa en nombre de menor o incapaz |
| **Herederos de Fallecido** | SÍ | Certificado de defunción y parentesco / posesión | Continuadores legales de los derechos |
| **Fiscalía / Tribunales** | SÍ | Oficio judicial en causa formal en trámite | Requerimiento de la justicia ordinaria |
| **Empleador Laboral** | NO | Prohibido absolutamente | Vulneración de datos personales sensibles |
| **Compañía de Seguros** | NO (salvo autorización) | Exige poder notarial expreso del paciente | El contrato privado no levanta el secreto médico |
| **Policía (Carabineros/PDI)** | NO (sin orden) | Requiere orden del Fiscal o Tribunal | La policía no puede revisar fichas autónomamente |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase sp-12

| SOLICITANTE | ¿TIENE ACCESO LEGAL? | FUNDAMENTO |
|---|---|---|
| **Adolescente de 15 años pide anticoncepción y reserva** | Se atiende con confidencialidad | Exigir que venga con sus padres |
| **Menor de 14 años con relación sexual** | Es delito: denunciar y proteger | Guardar reserva por confidencialidad |

**REGLA DE ORO** **La ficha es del paciente** — El establecimiento solo la custodia

**PRACTICA** **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **68–72** (págs. 20–21) · solucionario págs. 36–37.

**Clase 21.12 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO TIER 3

# 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

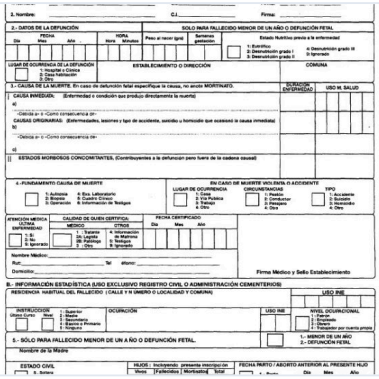
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

| | | |
|---|---|---|
| 7.01.3.051 | Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades | Conocimiento general |
| 7.01.3.052 | Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial | Conocimiento general |
| 5.01.3.008 | Maltrato infantil | Conocimiento general |
| 5.01.3.013 | Violencia intrafamiliar | Conocimiento general |
| 7.01.3.011 | Fuentes de información para el diagnóstico | Conocimiento general |

+ 2 códigos relacionados: 7.01.3.050 · 2.01.3.010

## LO QUE TE PREGUNTAN

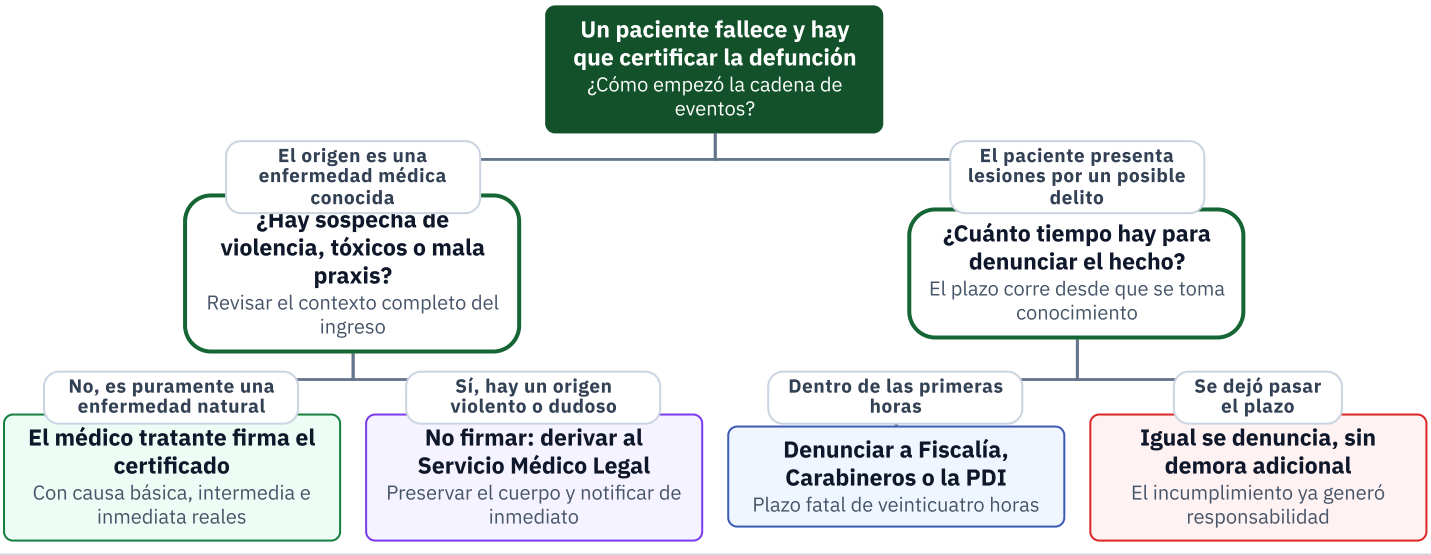
- **Causa Básica de Defunción**: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
- **¡PROHIBIDO!**: Nunca escribir 'Paro cardiorrespiratorio', 'Falla multiorgánica' o modos inespecíficos como causa única o básica.
- **Muerte Médico-Legal**: Homicidios, suicidios, accidentes, traumas, sospecha de delito e intoxicaciones; el médico NO firma el CMD.
- **Autopsia del SML**: Ordenada obligatoriamente por el Fiscal; la familia no puede oponerse; el médico legista firma el certificado.
- **Autopsia Clínica**: En muertes naturales hospitalarias con fines científicos; exige consentimiento firmado de la familia.



**CERTIFICADO VIGENTE**
Manual correcto llenado CMD (ESP U. de Chile / Colegio Médico), Anexo 2

## ALGORITMO · CERTIFICAR UNA DEFUNCIÓN: QUÉ FIRMAR Y A QUIÉN AVISAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.13 · MUERTE NATURAL VS MUERTE MÉDICO-LEGAL (SML)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-13

| CRITERIO DIFERENCIAL | MUERTE NATURAL (CERTIFICABLE) | MUERTE MÉDICO-LEGAL / VIOLENTA (SML) |
|---|---|---|
| **Causa Originaria** | Enfermedades médicas internas conocidas | Trauma, violencia, accidente, suicidio, tóxicos |
| **Quién Firma el CMD** | Médico tratante o de cabecera que constata | Exclusivamente el Médico Legista del SML |
| **Lugar de la Autopsia** | Hospital (Anatomía Patológica) si se solicita | Servicio Médico Legal (SML) por orden fiscal |
| **Consentimiento Familiar** | Exigible para autopsia clínica | NO aplica; la autopsia médico-legal es obligatoria |
| **Rol del Médico Clínico** | Completar correctamente el CMD en el INE | NO firmar certificado; llamar a Fiscalía / Carabineros |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase sp-13

| CRITERIO | MUERTE NATURAL | MUERTE MÉDICO-LEGAL |
|---|---|---|
| **Origen violento con muerte hospitalaria tardía** | No aplica | Sigue siendo médico-legal, aunque pasen semanas |

**REGLA DE ORO** **Básica, intermedia, inmediata** — Cada una, una enfermedad diagnosticable

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **40, 74–82** (págs. 16, 21–23) · solucionario págs. 31, 37–38.

**Clase 21.13 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

# 21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

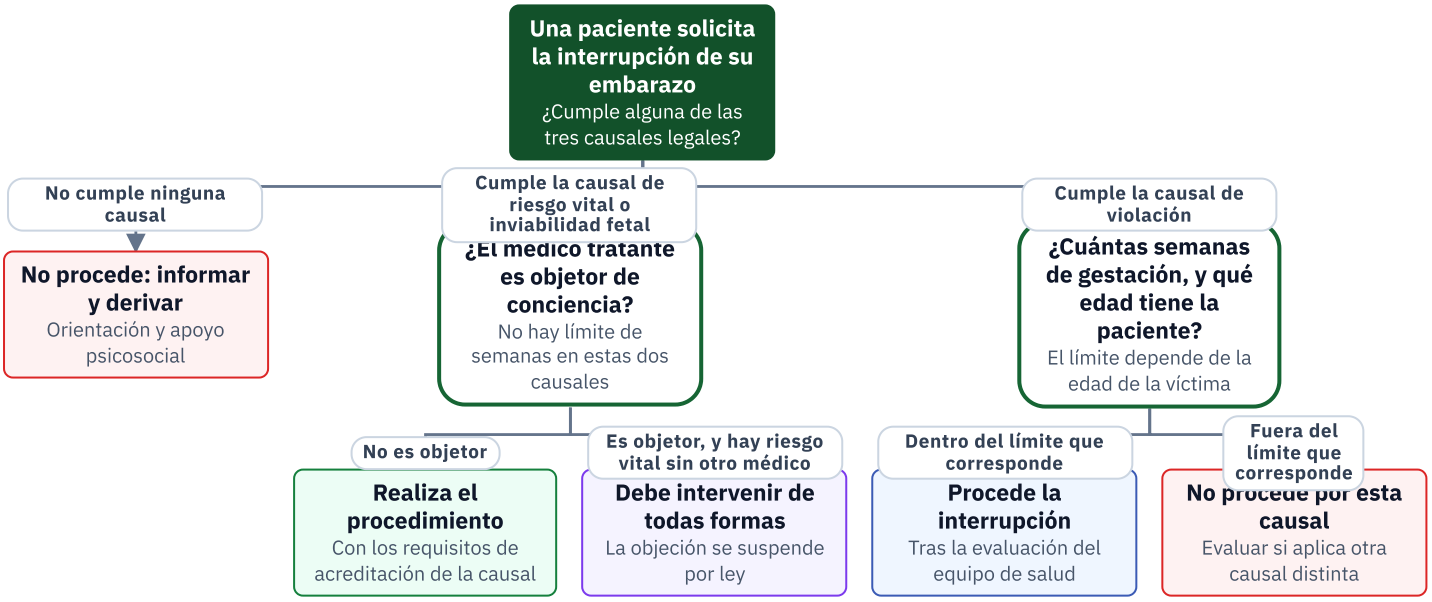
| | | |
|---|---|---|
| 7.01.3.052 | Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial | Conocimiento general |
| 7.01.3.054 | Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas | Conocimiento general |
| 3.01.3.002 | Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja | Conocimiento general |
| 1.11.3.001 | Condiciones de trabajo | Conocimiento general |
| 4.02.3.001 | Accidentes del trabajo | Conocimiento general |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ley IVE 21.030**: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).
- **Límites gestacionales IVE**: Causal 1 y 2 NO tienen límite gestacional; Causal 3 tiene tope de **12 semanas** (ampliable a **14 semanas** en menores de **14 años**).
- **Objeción de Conciencia**: Debe formularse previamente por escrito; obliga a la derivación inmediata a médico no objetor.
- **Excepción de Urgencia Vital**: En Causal 1 con riesgo de muerte materna inmediata y sin médico de reemplazo, el médico objetor DEBE intervenir forzosamente.
- **Código Sanitario (Art. 112/113)**: Reserva la prescripción diagnóstica y terapéutica exclusiva a médicos cirujanos (y odontólogos/matronas en su campo).
- **Ley 20.585 (Licencias Médicas)**: Penaliza la emisión fraudulenta de licencias médicas con penas de cárcel (presidio), multas millonarias e inhabilitación perpetua.

## ALGORITMO · DECIDIR FRENTE A UNA SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 21.14 · LAS TRES CAUSALES DE LA LEY IVE 21.030 EN CHILE

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE SP-14

| CAUSAL LEGAL | DEFINICIÓN MÉDICA | LÍMITE DE EDAD GESTACIONAL | REQUISITOS DE ACREDITACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Causal 1: Riesgo Vital** | Riesgo vital materno actual o inminente | SIN límite de edad gestacional | Médico tratante + 1 especialista (salvo urgencia vital) |
| **Causal 2: Inviabilidad Fetal** | Patología congénita incompatible con la vida extrauterina | SIN límite de edad gestacional | Diagnóstico concordante de 2 médicos especialistas |
| **Causal 3: Violación** | Embarazo resultante de agresión sexual | Hasta 12 semanas (14 semanas en < 14 años) | Evaluación de equipo psicosocial de salud |

**REGLA DE ORO** **Riesgo vital e inviabilidad: sin límite** — Violación: doce semanas, o catorce en menores

**PRACTICA** **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **83–90** (págs. 23–24) · solucionario págs. 38–40.

**Clase 21.14 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

# Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 15 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** | |
| **21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial** | pág. 3 |
| Financiamiento — Cotización **7%**, impuestos y copagos | CORTE |
| **21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos** | pág. 4 |
| Verifica estándares de calidad — Vigencia de **3 años** | CORTE |
| A los **6 años**: primer molar permanente — Sellantes, obturaciones y alta | CORTE |
| Anticoncepción y profilaxis — Levonorgestrel y antirretrovirales en **72 horas** | TIEMPO |
| **21.3 Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)** | pág. 5 |
| Copago en Ley Ricarte Soto: Es **100%** gratuita para el beneficiario (**0%** de copago). | CORTE |
| Copago del Usuario · **0%** Gratuito siempre para todos los beneficiarios · Copago máximo **20%** (según seguro y tramo) | CORTE |
| **21.15 Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección** | pág. 9 |
| Índice de envejecimiento — **≥ 65 años** / menores de **15 ×** 100 | CORTE |
| Razón de dependencia — (< 15 + **≥ 65**) / población de **15 a 64 ×** 100 | CORTE |
| Chile: fase avanzada — Fecundidad bajo el reemplazo, esperanza de vida cerca de **80 años** | CORTE |
| **BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE** | |
| **21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud** | pág. 12 |
| Hasta **42 días** tras el término — Causa relacionada o agravada por el embarazo; no accidental | TIEMPO |
| Significancia en IC **95%**: Si el intervalo de un RR u OR incluye el 1,0, NO existe significancia estadística (p **≥ 0,05**). | CORTE |
| **21.8 Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC** | pág. 14 |
| Área Bajo la Curva (AUC): AUC de 0,5 equivale al azar; AUC > 0,90 indica un test con excelente capacidad diagnóstica. | CORTE |
| **21.9 Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos** | pág. 15 |
| Error Aleatorio: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se evalúa con valor p e IC **95%**. | CORTE |
| **21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos** | pág. 16 |
| Desconfía de la sobrevida a **5 años** — Puede estar inflada por adelanto o duración | CORTE |
| **BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO** | |
| **21.12 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad** | pág. 18 |
| Menor de **14 años**: toda relación sexual es delito — Se denuncia y se protege | CORTE |
| **21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia** | pág. 19 |
| Denunciar en **24 horas** — Y pedir medida de protección al Tribunal de Familia | TIEMPO |
| Examen completo y estudio por edad — Radiografías de esqueleto en menores de **2 años**; fondo de ojo | CORTE |

# GES de Salud Pública y Bioética

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

**Sin garantía GES específica** (15 temas): 21.1 · 21.2 · 21.3 · 21.4 · 21.5 · 21.15 · 21.6 · 21.7 · 21.8 · 21.9 · 21.10 · 21.11 · 21.12 · 21.13 · 21.14. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

# Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

## DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **21.7** Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud ..... 12
- ★★★ **21.4** Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile ..... 6
- ★★★ **21.10** Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos ..... 16

**Practica:** Libro Gordo Salud Pública, preguntas 1–2, 14–15, 19–22, 38, 46–48, 56–61.

## DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **21.6** Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales ..... 10
- ★★★ **21.1** Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial ..... 3
- ★★☆ **21.15** Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección ..... 9

**Practica:** Libro Gordo Salud Pública, preguntas 3–12, 18, 29–37, 41–43, 55, 73.

## DÍA 3

3 temas · ★★

- ★★☆ **21.9** Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos ..... 15
- ★★☆ **21.14** Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas ..... 20
- ★★☆ **21.2** Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos ..... 4

**Practica:** Libro Gordo Salud Pública, preguntas 13, 39, 52–54, 83–90.

## DÍA 4

2 temas · ★★

- ★★☆ **21.8** Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC ..... 14
- ★☆☆ **21.5** Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario ..... 8

**Practica:** Libro Gordo Salud Pública, preguntas 16–17, 23–28, 45, 49–51.

## DÍA 5

2 temas · ★

- ★☆☆ **21.3** Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) ..... 5
- ★☆☆ **21.11** Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento ..... 17

**Practica:** Libro Gordo Salud Pública, preguntas 44, 62–67.

## DÍA 6

2 temas · ★

- ★☆☆ **21.13** Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia ..... 19
- ★☆☆ **21.12** Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad ..... 18

**Practica:** Libro Gordo Salud Pública, preguntas 40, 68–72, 74–82.

## DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» pág. 21
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 21.1 · 21.4 · 21.6 · 21.7 · 21.10
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Salud Pública en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

# Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

## ★★★ Prioridad alta · 5 temas


32 21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud ..... 12
20 21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile ..... 6
19 21.10. Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos ..... 16
18 21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales ..... 10
13 21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial ..... 3


## ★★ Prioridad media · 5 temas


10 21.15. Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección ..... 9
10 21.9. Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos ..... 15
10 21.14. Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas ..... 20
9 21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos ..... 4
8 21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC ..... 14


## ★ Prioridad baja · 5 temas


6 21.5. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario ..... 8
4 21.3. Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) ..... 5
4 21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento ..... 17
3 21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia ..... 19
1 21.12. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad ..... 18